

## Fundamento, jerarquía y aplicación clínica

### QUÉ ES

La exposición gradual consiste en enfrentar de forma sistemática y progresiva los estímulos temidos o evitados, para que el sistema nervioso aprenda que no son peligrosos. Es el tratamiento de primera línea para fobias, ansiedad social, TEPT y TOC. La evitación mantiene el miedo; la exposición lo extingue.

### FUNDAMENTO: HABITUACIÓN E INHIBICIÓN RECÍPROCA

#### Habitación (Mowrer)

- Con repetición, la respuesta de ansiedad disminuye naturalmente
- El cerebro aprende: "este estímulo no es peligroso"
- Requiere mantenerse en el estímulo hasta que la ansiedad baje
- No funciona si la exposición es demasiado breve

#### Inhibición recíproca (Wolpe)

- No se puede estar ansioso y relajado simultáneamente
- La relajación inhibe la respuesta de ansiedad
- Base de la desensibilización sistemática
- Puede combinarse con respiración diafragmática

### CONSTRUCCIÓN DE LA JERARQUÍA DE EXPOSICIÓN

#### 1. Listar estímulos temidos

Con el paciente, identificar todas las situaciones o estímulos que evita.

#### 2. Puntuar USAS

Unidades Subjetivas de Ansiedad (0-100) para cada ítem de la lista.

#### 3. Ordenar de menor a mayor

Típicamente 8-12 ítems ordenados por USAS ascendente.

#### 4. Definir el primer paso

Debe generar ansiedad leve (20-30 USAS) para asegurar éxito inicial.

### TIPOS DE EXPOSICIÓN

#### IN VIVO

- Exposición al estímulo real
- Mayor eficacia y generalización
- Primera línea en fobias
- A veces no es posible o práctica

#### IMAGINADA

- Visualización del estímulo
- Útil cuando in vivo no es viable
- Menos potente que in vivo
- Buena para preparar in vivo

#### INTEROCEPTIVA

- Exposición a sensaciones físicas
- Para pánico y fobias a sensaciones
- Provocar síntomas intencionalmente
- Muy eficaz en trastorno de pánico

### ERRORES FRECUENTES

Terminar la exposición cuando la ansiedad está alta (refuerza el miedo en vez de extinguirlo) · Saltar ítems de la jerarquía · Permitir señales de seguridad que impiden la habituación real · No preparar al paciente: "la ansiedad va a subir antes de bajar, eso es normal y esperado".